

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ



«Si vis pacem para bellum».

«Αν επιθυμείς ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο».

Publius Flavius Vegetius, 4^{ος} αιώνας μ.Χ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου, είτε υπηρετούμε σε Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, είτε σε κάποιο μικρό επαρχιακό νοσοκομείο, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια πληθώρα επειγόντων περιστατικών, ποικίλης βαρύτητας και φύσεως, οπότε θα χρειαστεί να αποφασίσουμε – αρκετές φορές υπό συνθήκες άγχους και χρονικής πίεσης – την άμεση παραπομπή ή όχι του ασθενούς ή τραυματία στο πλησιέστερο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο Νοσοκομείο, για περαιτέρω αντιμετώπιση ή/και διερεύνηση.

Ως «επείγον» χαρακτηρίζεται ένα κλινικό συμβάν, που περικλείει άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς. Οι όποιες ενέργειες απαιτούνται από τον ιατρό για να αποσοβηθεί κάποια σοβαρή, μη αναστρέψιμη για τον ασθενή βλάβη, οφείλουν να γίνουν έγκαιρα και γρήγορα, όχι όμως βιαστικά, ακολουθώντας ορισμένους κανόνες και κοινά αποδεκτούς αλγόριθμους και αφαιρώντας τις οποιεσδήποτε παρωπίδες και θέσφατα.

Η αντιμετώπιση του επείγοντος συμβάντος, είναι ομαδική εργασία. Ο ιατρός με τους νοσηλευτές ή τους διασώστες, αποτελούν την ομάδα αντιμετώπισης του επείγοντος. Κάθε μέλος της ομάδας, γνωρίζει σαφώς και εκ των προτέρων τα καθήκοντά του και τη θέση του στην ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται οι καθημερινές «κρίσεις πανικού» και οι συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να θέτουν την υγεία και τη ζωή του ασθενούς - αλλά και των μελών της ομάδας - σε κίνδυνο και να καθιστούν την ομάδα δυσλειτουργική.

Γενικά, ο αλγόριθμος που πάντοτε πρέπει να εφαρμόζεται όταν ο ιατρός έρχεται σε πρώτη επαφή με τον βαρέως πάσχοντα ασθενή – αλλά και αργότερα – είναι ο Α-Β-С-D-E (βλ. σελ. 252, κεφ. 19 - «Πολυτραυματίας»). Εφαρμόζεται ευρέως και με «ευλάβεια», τόσο σε παθολογικά όσο και σε τραυματολογικά περιστατικά, είτε σε παιδιά, είτε σε ενήλικες.

Η απόφαση τελικά, για την παραπομπή του ασθενούς στο νοσοκομείο, πρέπει να σταθμίζεται με βάση την κλινική εικόνα, το ιστορικό, τη βάσιμη υποψία για περαιτέρω κλινική επιδείνωση και την αδήριτη ανάγκη για νοσηλεία και αντιμετώπιση του ασθενούς από τον ειδικό (βλ. σελ. 376). Αρκετές φορές σημαίνοντα ρόλο στην απόφαση για διακομιδή δεν παίζουν μόνον ιατρικοί λόγοι, αλλά κοινωνικοί, γεωγραφικοί, ενίοτε και οικονομικοί.

Ακόμη πιο σημαίνοντα ρόλο στην έκβαση της υγείας ενός ασθενούς διαδραματίζει η απόφαση του ιατρού να στείλει τον ασθενή σπίτι του, μετά από μια επιτυχή θεραπευτική παρέμβαση, με τα όποια πενιχρά μέσα διαθέτει στο ΠΙ ή στο ορεινό/νησιωτικό ΚΥ.

Τελικά, πολλές φορές, ο νέος κι άπειρος ιατρός που υπηρετεί στην ύπαιθρο, διερωτάται με αγωνία και αμηχανία: «*Παραπομπή στο νοσοκομείο: ποιος, πότε και με τι παραπέμπεται;*»

Γενικά, οι ασθενείς που προσέρχονται στο ΤΕΠ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Άτομα τα οποία μετά από εξέταση και κατάλληλες οδηγίες στέλνονται στο σπίτι τους.
2. Ασθενείς οι οποίοι πρέπει να παρακολουθηθούν για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (παραμονή στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας - MBN, συνήθως μερικών ωρών) μέχρι να αποφασιστεί αν θα σταλούν στο σπίτι τους ή θα παραπεμφθούν τελικά στο νοσοκομείο.
3. Ασθενείς με σοβαρό νόσημα, που αναμφίβολα πρέπει να διακομισθούν με ασθενοφόρο και να νοσηλευθούν σε νοσοκομείο, αλλά δεν απειλείται άμεσα η ζωή τους.
4. Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, των οποίων απειλείται άμεσα η ζωή και πρέπει - αφού σταθεροποιηθούν στο ΚΥ - να μεταφερθούν με ασθενοφόρο, τάχιστα, στο νοσοκομείο.

Αφού εξετάσουμε κλινικά τον ασθενή, λάβουμε ένα σύντομο και στοχευμένο ιστορικό, ελέγξουμε το βιβλιάριο ή το ΑΜΚΑ του για τα φάρμακα που λαμβάνει, τότε μπορούμε να κατατάξουμε τον ασθενή μας σε μία από τις παραπάνω ομάδες και να δράσουμε ανάλογα.

Ουσιαστικά λοιπόν, στο ιατρείο της ΠΦΥ ή στο Κέντρο Υγείας, τα διαθέσιμα συνήθως μέσα για την άμεση αξιολόγηση ενός επείγοντος περιστατικού είναι: Το ιστορικό, η φυσική εξέταση, η μέτρηση σακχάρου αίματος (dextrostick), η παλμική οξυμετρία και το ΗΚΓ και λιγότερο συχνά ο εργαστηριακός ή ο ακτινολογικός έλεγχος. Άρα, το κύριο βάρος για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού πέφτει πρωτίστως στην επιστημονική επάρκεια

του ιατρού, στην ορθή χρήση των κατευθυντήριων οδηγιών, στις κλινικές δεξιότητες που διαθέτει, στην όποια κλινική εμπειρία του και τέλος στις συμβουλές ή οδηγίες που μπορεί να αντλήσει άμεσα (ακόμα και μακρόθεν - τηλεϊατρική) από εμπειρότερους συναδέλφους.

Βασικό ερώτημα, στην πρώιμη αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού, είναι αν ο ασθενής που εξετάζουμε ή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι σταθερός ή ασταθής.

Σημεία κλινικής αστάθειας που μπορεί να εμφανίσει ο ασθενής μας, αποτελούν τα εξής:

- ♦ Υπόταση (ΣΑΠ < 90 mmHg ή ΜΑΠ < 65 mmHg),
- ♦ Σοβαρή υπέρταση (ΣΑΠ/ΔΑΠ > 220/110 mmHg),
- ♦ Ταχυσφυγμία (σφύξεις - HR > 140-150 παλμοί/min),
- ♦ Βραδυκαρδία (σφύξεις - HR < 40 παλμοί/min),
- ♦ Ταχύπνοια (αναπνοές - RR > 30/min),
- ♦ Βραδύπνοια (αναπνοές - RR < 10/min),
- ♦ Υποξυγοναιμία (SpO₂ < 90% ή PaO₂ < 60 mmHg).



Παράλληλα, κατά την κλινική εξέταση και τη θεραπευτική παρέμβαση ή την παραμονή του ασθενούς στο ΤΕΠ, μπορεί να εμφανιστούν **συμπτώματα κλινικής αστάθειας**, όπως:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ♦ αίσθημα παλμών, | ♦ θωρακικό άλγος, |
| ♦ ζάλη, ίλιγγος, αστάθεια, | ♦ πνευμονικό οίδημα, |
| ♦ συγκοπτικό επεισόδιο, | ♦ μείωση του επιπέδου συνείδησης, |
| ♦ δύσπνοια / ορθόπνοια, | ♦ καταπληξία (shock). |

Με βάση τα παραπάνω σημεία και συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής, κι εφόσον, τελικά, χαρακτηρίζεται σαν ασταθής, οργανώνουμε το πλάνο για τη **σταθεροποίηση**, το **συνεχές monitoring** και την άμεση κι ασφαλή **διακομιδή** του στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Παράλληλα όμως με την απόφαση για διακομιδή, πρέπει να γίνει και μια πρώτη ταχεία **διαγνωστική προσέγγιση** και να ξεκινήσει η **βασική θεραπευτική αντιμετώπιση**.

Οι άμεσοι στόχοι της σταθεροποίησης του ασθενούς και δη του βαρέως πάσχοντος, είναι:

1. Η διασφάλιση του αεραγωγού, καθώς και σταθεροποίηση της αυχενικής μοίρας της ΣΣ (ΑΜΣΣ), ειδικά στις περιπτώσεις τραυματισμού της κεφαλής ή του αυχένα (Α).
2. Ο επαρκής αερισμός και η οξυγόνωση του ασθενούς, με διάφορους τρόπους (Β).
3. Η ενδεδειγμένη ενδοφλέβια ή ενδοοστική προσπέλαση, για την άμεση αναπλήρωση του ενδαγγειακού όγκου και τη σταθεροποίηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων (C).
4. Η εξέταση του επιπέδου συνείδησης και η αδρή νευρολογική εκτίμηση (D).
5. Η πλήρης έκδυση του ασθενούς ή του τραυματία. Ο ενδεδειγμένος έλεγχος για κακώσεις ή βλάβες που διέφυγαν της προσοχής μας και η ταυτόχρονη προστασία από το ψύχος (E).



Η χορήγηση οξυγόνου, η εξασφάλιση ενδοφλέβιας προσπέλασης, καθώς και ο έλεγχος κάθε μείζονος απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας, είναι οι άμεσες προτεραιότητες· ενώ ο αλγόριθμος Α-Β-С-D-E πρέπει να διέπει από αρχής μέχρι τέλους την αντιμετώπιση σε κάθε επείγον περιστατικό, είτε σε προνοσοκομειακό περιβάλλον, είτε στο χώρο του ΤΕΠ.

Παράλληλα, η αντιμετώπιση οποιασδήποτε εμφανούς αιτίας η οποία ευθύνεται για την αστάθεια του ασθενούς (π.χ. πνευμοθώρακας υπό τάση, αιμορραγία, OEM, έντονο άλγος που προκαλεί υπέρταση, ισχαιμία ή αρρυθμία, κ.ά.) πρέπει να πραγματοποιείται στον ίδιο χρόνο με την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Α-Β-С-D-E και φυσικά πριν τη διακομιδή του ασθενούς σε τριτοβάθμιο κέντρο, εφόσον αυτή αποφασιστεί.

Αντιθέτως, όταν ο ασθενής εμφανίζεται σταθερός, τότε ο ιατρός διαθέτει, θεωρητικά, την ευχέρεια χρόνου για πιο λεπτομερή εξέταση και αξιολόγηση του περιστατικού (πλήρες ιστορικό, φυσική εξέταση, εργαστηριακός - απεικονιστικός έλεγχος, επανεξέταση, κ.λπ.).

Πρέπει όμως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ο σταθερός ασθενής μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταστεί ασταθής. Για αυτό απαιτείται πάντοτε τακτικός έλεγχος των ζωτικών σημείων, κλινική επανεκτίμηση και ουδόλως εφησυχασμός. Η αξιολόγηση και η ενδεδειγμένη παρακολούθηση θα καθορίσουν την κλινική απόφαση για το εάν ο ασθενής χρήζει παραπομπής στο νοσοκομείο, σε ποια χρονική στιγμή και υπό ποιες συνθήκες.